

☒ ACOMPANHAMENTO () CONSULTA
NS 222 3325 0358 / 199

MARIA DO CARMO DE LIMA SAMPAIO

IDADE: 54 PESO: 90 ALTURA: 1,67 PROFISSÃO: Comerciante Papalária
SINTOMAS: Dor de cabeça / Refluxo.
QUEIXAS: Quase não dorme (dispertha) - Sonolência - Cansaço
MEDICAMENTOS: Glifage } Queixa de barrigão
DM } esquecida
MÉDICO: Dr. Daniels Caudoro
MARCAPASSO: () S (X) N / COMPANHEIRO(A) USA MARCAPASSO: () S (X) N
EXERCÍCIO FÍSICO: Hidroginástica (2x)
HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ: 5 ALMOÇO: 5 LANCHE: 5 JANTAR: 5 (19h)
HORA QUE DORME: 23:30 HORA QUE ACORDA: 4h
COCHILHO (X) SIM () NÃO DORME ACOMPANHADO (X) SIM () NÃO () EVENTUAL
BEBIDA ALCOÓLICA () SIM () X NA SEMANA (X) NÃO
FUMO () SIM () MAÇO/DIA (X) NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:
TIPO DE RESPIRAÇÃO: mista BANHEIRO: 2 a 3x
CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:
OVERLAP: Asma MALLAMPATI: IV (++) IAH: 66.7 SPO2: 51%
PATOLOGIAS ASSOCIADAS: CA marra (2018) - Apendicite (superior)
CIRURGIAS: () NASAL () AMIGDALECTOMIA Desvio Septo.
HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE: n IMC: 32.24
COMORBIDADE: (N) RESPIRATÓRIA (N) ENDÓCRINA (N) CARDÍACA
(S) ORTOPÉDICA (S) NEUROLÓGICA () OUTROS Dor lombar/cerv.

16/07 Análise + Comprou Autoset FH mare guilherme

26/07/24 P = 4-10 cmH2O
IAH = 3,1 e/h Utilizou 3 dias por causa da alergia
m de uso: 6h20
Natacha

10/09/24 P = 7-10 cmH2O
IAH = 1,1 e/h Bem adaptada
m de uso: 9h15
Natacha

12/11/24 P = 9,6 cmH2O (mediana)
IAH = 1,6 e/h Bem adaptada
m de uso: 9h6' Troca filtro
fluxo: 6,1 l/m
Natacha

03/07/25 -> Vire

04/02/25

P = 9,6 cm H₂O (mediana)

IAH = 1,3 cl/h

m de uso: 9h35

fuga: 7,3 l/m

Bem adaptada

6) quilos

Natasha

03/07
25

P = 9,6 cm H₂O

IAH = 0,8 efv

M. de uso = 9h

fuga = 9,6 lpm

Bem adapt.

fua.

Nome: MARIA DO CARMO DE LIMA SAMPAIO

Data de Nascimento: 4-5-1970

IMC: 32,27

Sexo: Feminino

Data do exame: 16-06-2024

Peso: 90 kg

Altura: 1,67 m

Médico: DR. DANIEL CAUDORO SALGADO

Medicamentos:

Histórico:

Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 16-06-2024, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 569,5 min. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 24,0 e 188,5 minutos. O tempo total de sono foi de 415,0 min, eficiência de 72,9% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 2,2%; estágio N2: 68,2%; estágio N3: 9,5%; sono REM: 20,1%. O índice de despertares foi de 35,7/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 66,7/hora, sendo 0 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 455 hipopnéias. A SpO2 média foi de 91% e a mínima de 51%, permanecendo 16,7% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 50 - 85 bpm e NREM de 49 - 111 bpm.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (10), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do estágio N3 do sono NREM diminuída e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 66,7/hora;
4. houve dessaturação da oxihemoglobina (min. SaO2=51%);
5. latência para o sono REM aumentada;
6. aumento do número de despertares breves;
7. registro de ronco durante o sono.

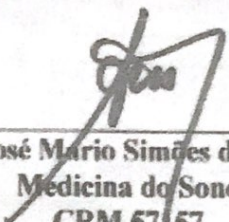
Exame evidenciando apneia obstrutiva do sono e dessaturação de graus acentuados.

IAH: 05-15 /hora leve.

IAH: 15-30 /hora moderada.

IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57/57